BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemograma Completo
Material:
Sangue
Método:
Analisador Automatizado (Contagem por impedância e análise celular por citometria de fluxo)
SÉRIE VERMELHA
Valores de Referência
Hemácias
4,010
milhões/mm3
4,5 a 5,9 milhões/mm3
Hemoglobina
12,00
g/dL
13,5 a 17,5 g/dL
Hematócrito
36,00
%
41,0 a 53,0 %
V.C.M.
89,78
fL
80,0 a 98,0 fL
H.C.M.
29,93
pg
27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.
33,33
g/dL
31,0 a 35,0 g/dL
R.D.W. (CV)
13,20
%
11,5 a 14,5 %
R.D.W. (SD)
43,40
fL
38,6 a 49,1 fL
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS
5,93
milhares/mm3
5,0 a 10,0 milhares/mm3
(%)
milhares/mm3
Blastos
0,00
0,00
Ausentes
Pro-mielócitos
0,00

0,00
Ausentes
Mielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Metamielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Neutrófilos Bastonetes
3,00
0,18
0 a 3 % (Até 830/mm3)
Neutrófilos Segmentados
45,80
2,72
35 a 75 % (1.520 a 4.980/mm3)
Eosinófilos
3,40
0,20
0 a 3 % (30 a 400/mm3)
Basófilos
1,30
0,08
0 a 1 % (Até 80/mm3)
Linfócitos típicos
35,90
2,13
20 a 50 % (900 a 3.400/mm3)
Linfócitos atípicos
0,00
0,00
Ausentes
Monócitos
10,60
0,63
2 a 10 % (240 a 680/mm3)
Células Indiferenciadas
0,00
0,00
Ausentes
PLAQUETAS
162,0
milhares/mm3
140 a 400 milhares/mm3
M.P.V.
12,00
fL
7,5 a 11,5 fL
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 17:22:29
* Amostra processada pelo analisador automático Sysmex Série-X.

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Glicemia de Jejum .....:
138
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico Enzimático (Glicose-Oxidase)
V.R.:
Normal .....: 65 a 99 mg/dL
Pré-Diabetes .....: 100 a 125 mg/dL
Diabetes .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/)
Gestantes:
Normal .....: Inferior a 92 mg/dL
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) .....: De 92 a 125 mg/dL
Diabetes Mellitus diagnosticado na gestação .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/rastreamento-e-diagnostico-da-hiperglicemia-na-gestacao/)
Obs. 1: DEVE SER CONSIDERADO estabelecer o diagnóstico de DM na presença de glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL e HbA1c igual ou superior a 6,5% em uma mesma amostra de sangue.
Obs. 2: Com o intuito de não postergar o início de tratamento em situações agudas, o diagnóstico de DM poderá ser feito por meio de glicemia "ao acaso" (fora do estado metabólico de jejum) com valor igual ou superior a 200 mg/dL, quando na presença de sintomas inequívocos de hiperglicemia.
Fonte: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2024) https://diretriz.diabetes.org.br/
IMPORTANTE:
Estes Valores de Referência NÃO SE APLICAM para "Glicemia ao acaso" (SEM CUMPRIR JEJUM de 8 a 12h).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
21/06/2022 - 13:27:39

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemoglobina Glicada (HbA1c)
Material:
Sangue Total (EDTA)
Método:
HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance) - Retenção Iônica (Mindray H-120)
Resultado.....:
7,3
%
Anteriores:
V.R.:
Para a finalidade de DIAGNÓSTICO do Diabetes: META a ser alcançada para os valores de HbA1c no CONTROLE do Diabetes:
Indivíduos não diabéticos: 4,4 a 5,6 % Faixa pré-puberal: Manter inferior a 8,0 %
Pré-Diabetes.....: 5,7 a 6,4 % Faixa puberal....: Manter inferior a 8,5 %
Diabetes.....: Maior ou igual a 6,5 % Adultos.....: Manter inferior a 7,0 %
Ref.: Sociedade Brasileira de Diabetes (2024): https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/
Linearidade do método utilizado: 3,1% a 19,5%.
Glicemia MÉDIA Estimada (GME) :
163
mg/dL
Anteriores:
V.R.:
Desejável (Controle excelente/Não diabéticos): Inferior a 117 mg/dL
Limítrofes (Pré-Diabetes).....: Entre 117 e 139 mg/dL
Elevado (Diabetes mal controlado) .....: Superior a 139 mg/dL
IMPORTANTE: Método Certificado pelo NGSP (USA),padronizado e rastreável ao ensaio de referência do DCCT/IFCC.
Evidência: https://ngsp.org/docs/methods.pdf (page 17) - NGSP: National Glycohemoglobin Standardization Program. - DCCT:
Diabetes Control and Complications Trial. - IFCC: International Federation of Clinical Chemistry.
*GME (Glicemia MÉDIA Estimada) ou ADAG (do inglês: A1C-Derived Average Glucose) corresponde ao valor MÉDIO da glicemia dos últimos 90 dias, independente do estado
metabólico do paciente (presença ou ausência de jejum, períodos pós-prandiais, períodos sub ou sobre-alimentados). O valor da GME não deve ser comparado à Glicemia em
jejum, pois apresentam faixas de corte diferentes, uma vez que os valores de GME não estão restritos ao estado metabólico de jejum.
Os infográficos a seguir ilustram a correlação e estratificação dos níveis de HbA1c e GME, auxiliando a
interpretação dos resultados obtidos:
Observação: "É RECOMENDADO estabelecer o diagnóstico de DM se houver glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL e HbA1c maior ou igual a 6,5%, simultaneamente. Na ausência de glicemia de jejum simultanea acima de 125 mg/dL, a dosagem de HbA1c deve ser
confirmada com obtenção de nova amostra". Ref.: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2024), disponível em:
https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberacao:
20/06/2022 - 17:22:29

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Creatinina
Material :
Sangue
Metodo :
Colorimétrico Automatizado (Picrato/Jaffé)
Resultado .....:
1,23
mg/dL
VR:
Masculino (> 12 anos): 0,7 a 1,3 mg/dL
Importante: Atentar para elevação dos valores de Creatinina em pessoas que estejam realizando uso de suplementação de Creatina. Esta elevação pode ser
suficiente para falsear os valores de eTFG, induzindo à suspeita de perda de função renal artificialmente. Ref.: DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21867
Ritmo de Filtração Glomerular Estimado p/ 1,73 m²(eTFG):
mL/min
A eTFG relatada é baseada na equação
CKD-EPI 2021
que não usa coeficiente racial. Os valores da eTFG, baseados na equação
eGFRcr CKD-EPI 2021
, precisam ser
interpretados com base no contexto clínico. As recomendações da prática clínica sugerem solicitar cistatina C como teste confirmatório para pacientes com eTFG de 45-59
mL/min/1,73m2 com RAC < 30 mg/g, e em pacientes para os quais a creatinina pode ser um indicador menos confiável de eTFG próximo à decisão pontos. Situações em que
fatores não relacionados à TFG podem ter um grande efeito na creatinina sérica incluem alterações na geração de creatinina (doenças de perda muscular, amputados,
fisiculturistas, dieta vegana, suplementação com Creatina), medicamentos que afetam a secreção tubular de creatinina (cimetidina, cobicistate, dolutegravir, fenofibrato, ritonovir,
trimetoprim e outros) e condições com eliminação extra-renal de creatinina (perdas gastrointestinais e do “terceiro espaço”).
Ref.:
https://www.kidney.org/content/national-kidney-
foundation-laboratory-engagement-working-group-recommendations-implementing ;
https://arquivos.sbn.org.br/pdf/biomarcadores.pdf ; https://www.rbac.org.br/artigos/taxa-de-
filtracao-glomerular-estimada-em-adultos/
Critérios para DRC: Qualquer uma das seguintes condições, PRESENTES POR MAIS DE 3 MESES: Albuminúria/Creatininúria: (RAC ≥ 30 mg/g) ; Anormalidades no sedimento
urinário ; Eletrólitos e outras anormalidades devido a distúrbios tubulares ; Anormalidades detectadas por histologia ; Anormalidades estruturais detectadas por imagem ; História
do transplante renal ; TFG reduzida TFG <60 ml/min/1,73 m2. Abreviaturas:
DRC
(Doença Renal Crônica);
TFG
(Taxa de Filtração Glomerular). Fonte:
https://www.kidney.org/professionals/explore-your-knowledge/what-is-the-criteria-for-ckd.
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberacao:
20/06/2022 - 23:07:52
Dosagem de Ureia / Nitrogênio Ureico (BUN)
Material :
Sangue
Metodo :

Cinética UV - Urease
Nitrogênio Ureico (BUN)..:
20,6
mg/dL
VR:
9 a 20 mg/dL
Ureia.....:
44,0
mg/dL
VR:
Ureia em Adultos (Masculino): 19 a 50 mg/dL
Nitrogênio Ureico em Adultos (Masculino): 9 a 23 mg/dL
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberacao:
21/06/2022 - 13:27:39

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Potássio .....:
4,3
mEq/L
Material :
Sangue
Método :
Potenciometria/Eletrodo Seletivo
V.R.:
3,5 a 5,5 mEq/L
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 23:02:51
Dosagem de Sódio .....:
141
mEq/L
Material :
Sangue
Método :
Potenciometria/Eletrodo Seletivo
V.R.:
135 a 145 mEq/L
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 23:02:51

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Colesterol Total...:
112
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Enzimático-colorimétrico - CHOD-PAP
V.R.:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
| < 190 mg/dL | < 190 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq
Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Valores de Colesterol Total ≥ 310 mg/dL (para adultos) ou ≥ 230 mg/dL (crianças e adolescentes) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas
as dislipidemias secundárias.
A HF é a mais comum entre as dislipidemias e seus portadores tem 20 vezes mais risco de morte precoce por Doença Cardiovascular.
Fonte
:
Sociedade Brasileira de Cardiologia -
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose;
Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 23:16:10
Determinação de Colesterol-HDL e Não-HDL
Material:
Sangue
Metodo:
Enzimático Colorimétrico
Colesterol - HDL.....:
27
mg/dL
VR:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
Adultos (> 20 anos)| > 40 mg/dL | > 40 mg/dL | Desejável |
(De 0 a 19 anos)| > 45 mg/dL | > 45 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras
Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Dosagem de Colesterol presente nas HDL (Lipoproteínas de Alta Densidade), também conhecido como HDL1.
Colesterol Não-HDL...:
85
mg/dL
VR:
| Metas Desejáveis por Categoria de Risco Cardiovascular Pré-Estabelecido |
Categoria de Risco	Com jejum	Sem Jejum
Baixo	< 145 mg/dL	< 145 mg/dL
Intermediário	< 130 mg/dL	< 130 mg/dL
Alto	< 100 mg/dL	< 100 mg/dL
Muito Alto	< 80 mg/dL	< 80 mg/dL

| Extremo | < 70 mg/dL | < 70 mg/dL |

Obs.: Os valores de referência para "Colesterol Não-HDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas de acordo com o risco cardiovascular calculado de cada pessoa, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.

Colesterol presente nas demais Lipoproteínas que não a HDL, a saber: Colesterol presente nas LDL, VLDL, IDL e Quilomícrons.

Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00

Data/Hora Liberacao:
20/06/2022 - 23:16:10

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Colesterol - LDL .....:
62
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Conforme descrito por Martin et al., 2013
V.R.:
| METAS DESEJÁVEIS por Categoria de Risco Cardiovascular Pré-Estabelecido |
Categoria de Risco	Com jejum	Sem Jejum
Baixo	< 115 mg/dL	< 115 mg/dL
Intermediário	< 100 mg/dL	< 100 mg/dL
Alto	< 70 mg/dL	< 70 mg/dL
Muito Alto	< 50 mg/dL	< 50 mg/dL
Extremo	< 40 mg/dL	< 40 mg/dL
Obs.: Os valores de referência para "Colesterol-LDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas de acordo com o risco cardiovascular calculado de cada pessoa, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Literatura sugerida:
https://diretriz.diabetes.org.br/manejo-do-risco-cardiovascular-dislipidemia/ (Pacientes diabéticos / Síndrome metabólica).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 23:16:10
Dosagem de Triglicerídeos .....:
150
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico enzimático - Oxidase/Peroxidase
V.R.:
Crianças: 0 a 9 anos | 10 a 19 anos | Acima de 20 anos |
Com Jejum 12h: Inferior a 75 mg/dL | Inferior a 90 mg/dL | Inferior a 150 mg/dL |
Sem Jejum 12h: Inferior a 85 mg/dL | Inferior a 100 mg/dL | Inferior a 175 mg/dL |
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas. Obs: Para pacientes com resultado de Triglicerídeos > 800 mg/dL utilizar os valores de Não-HDL Colesterol como METAS ao invés dos valores de LDL. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas.
"A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e a estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas". Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (versão 1.13).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 23:09:53

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2022-06-20 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Urina Tipo I - Elementos Anormais e Sedimentoscopia (EAS)
Material:
Urina Jato Medio
Método:
Análise Química (Tira) / Reflectância Automatizada / Citometria de Fluxo / Microscopia (Óptica e/ou Digital).
Resultados:
Valores de Referência:
Caracteres gerais:
Aspecto
Límpido
Límpido
Cor
Amarelo Claro
Amarelo claro a Amarelo
Densidade
1,015
1,015 a 1,025
pH
6,5
5,0 a 7,5
Elementos anormais:
Relação Albumina/Creatinina (RAC)
0
mgAlb/gCr
Inferior a 30 mgAlb/gCr
Proteínas
0
mg/dL
0 mg/dL
Glicose
0
mg/dL
0 mg/dL
Corpos Cetônicos
0
mg/dL
0 mg/dL
Bilirrubinas
0
mg/dL
0 mg/dL
Urobilinogênio
1,4
mg/dL
Inferior a 2,0 mg/dL
Nitrito
Negativo
Não Reagente
Sedimentoscopia:
Sangue (Hemácias/Hemoglobina)
0,00
mg/dL

Inferior a 0,03 mg/dL
Leucócitos/Piócitos
0
Ausência (LD ~ 5 leu/uL)
Células Epiteliais Escamosas
0
/uL
Inferior a 25/uL
Células Epiteliais Não Escamosas
0
/uL
Inferior a 10/uL
Leveduras
Ausente
Ausente
Microbiota (Bactérias)
Ausente
Ausente
Filamentos de Muco
Ausente
Ausente
Cristais
Ausente
Ausente
Cilindros
Ausente
Ausente
Obs.1: Pacientes em uso de inibidores da SGLT2 (reabsorção tubular de glicose) ex: Dapagliflozina, empaglifozina, canagliflozina e ertugliflozina) apresentam glicosúria mesmo com glicemia normal.
Obs.2: Presença de agentes redutores como ácido ascórbico por levar a resultados falsos-negativos para hemoglobinúria. A presença de Mioglobina, medicamentos contendo grupo SH (ex: Glutationa,
bucilamina) e agentes oxidantes (Hipoclorito de sódio, ácido hipocloroso) pode gerar resultados falsos-positivos para hemoglobinúria.
Obs.3: RAC até 30 mgAlb/gCr = Normal; Entre 30 e 300 mgAlb/gCr = Microalbuminúria; Valores >= 300 mgAlb/gCr = Macroalbuminúria.
Data/Hora Coleta:
20/06/2022 - 12:45:00
Data/Hora Liberação:
20/06/2022 - 14:40:59